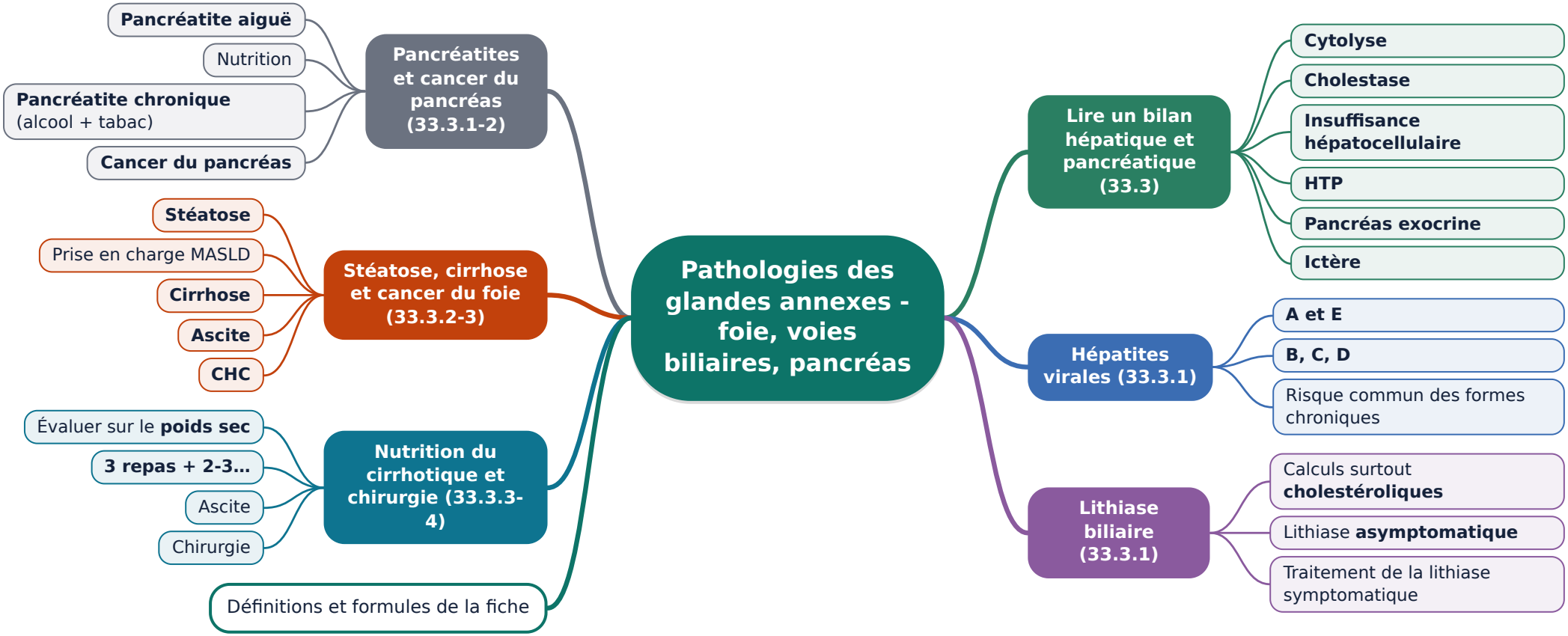
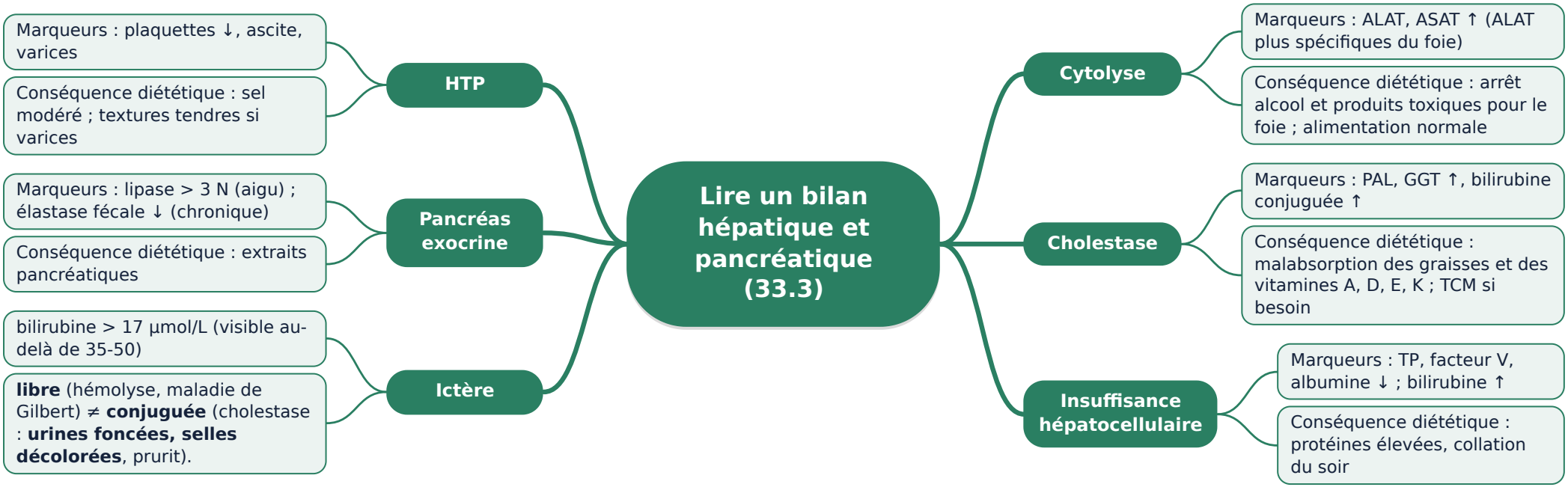
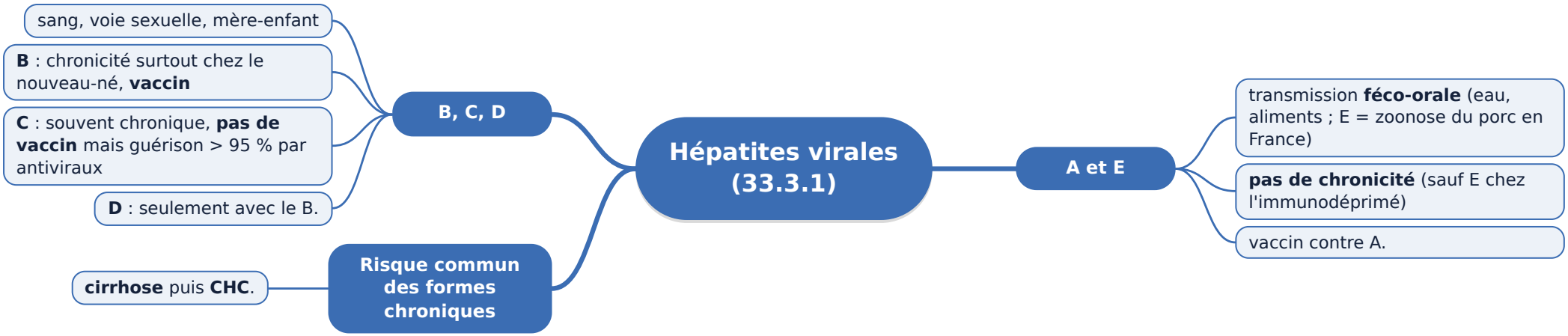
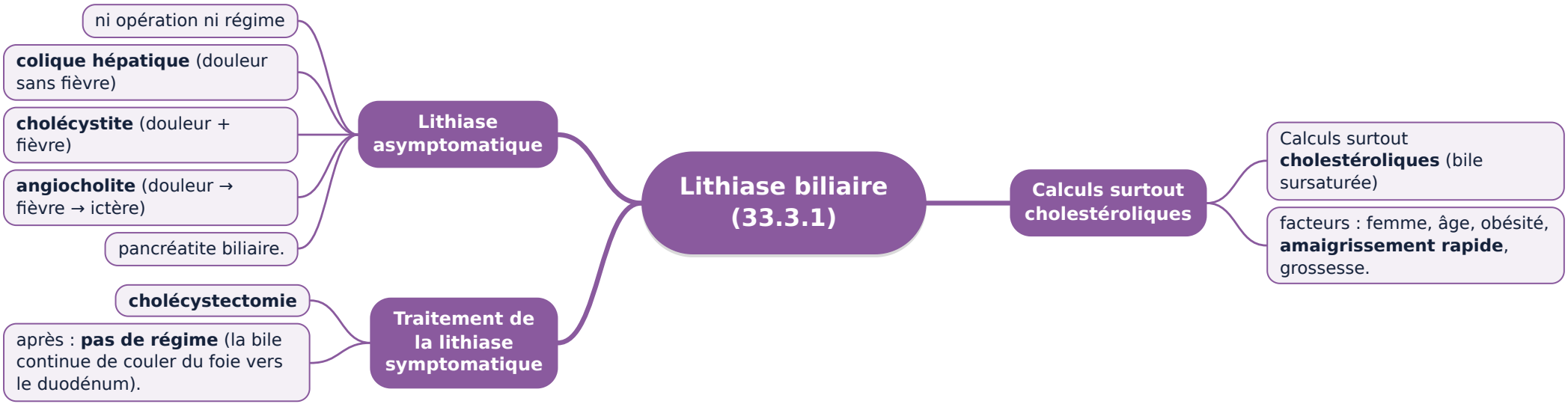
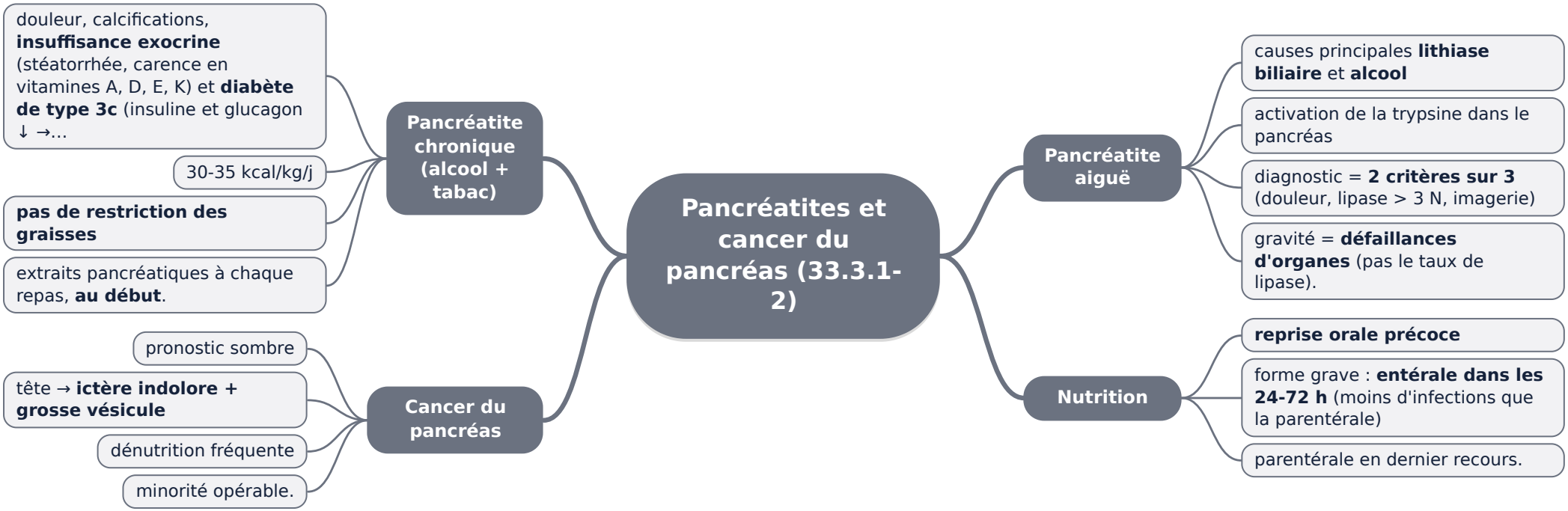
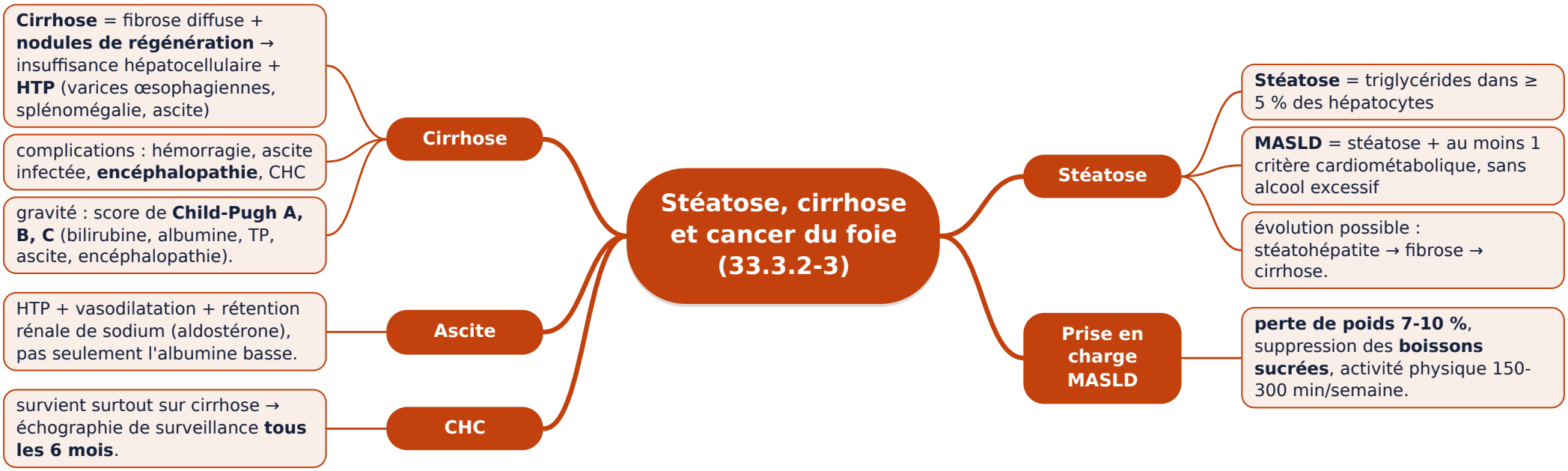

Pathologies des glandes annexes - foie, voies biliaires, pancréas
Pancréatites et cancer du pancréas (33.3.1-2)
Pancréatite aiguë
Nutrition
Pancréatite chronique (alcool + tabac)
Cancer du pancréas
Stéatose, cirrhose et cancer du foie (33.3.2-3)
Stéatose
Prise en charge MASLD
Cirrhose
Ascite
CHC
Nutrition du cirrhotique et chirurgie (33.3.3-4)
Évaluer sur le poids sec
3 repas + 2-3…
Ascite
Chirurgie
Définitions et formules de la fiche
Lire un bilan hépatique et pancréatique (33.3)
Cytolyse
Cholestase
Insuffisance hépatocellulaire
HTP
Pancréas exocrine
Ictère
Hépatites virales (33.3.1)
A et E
B, C, D
Risque commun des formes chroniques
Lithiase biliaire (33.3.1)
Calculs surtout cholestéroliques
Lithiase asymptomatique
Traitement de la lithiase symptomatique

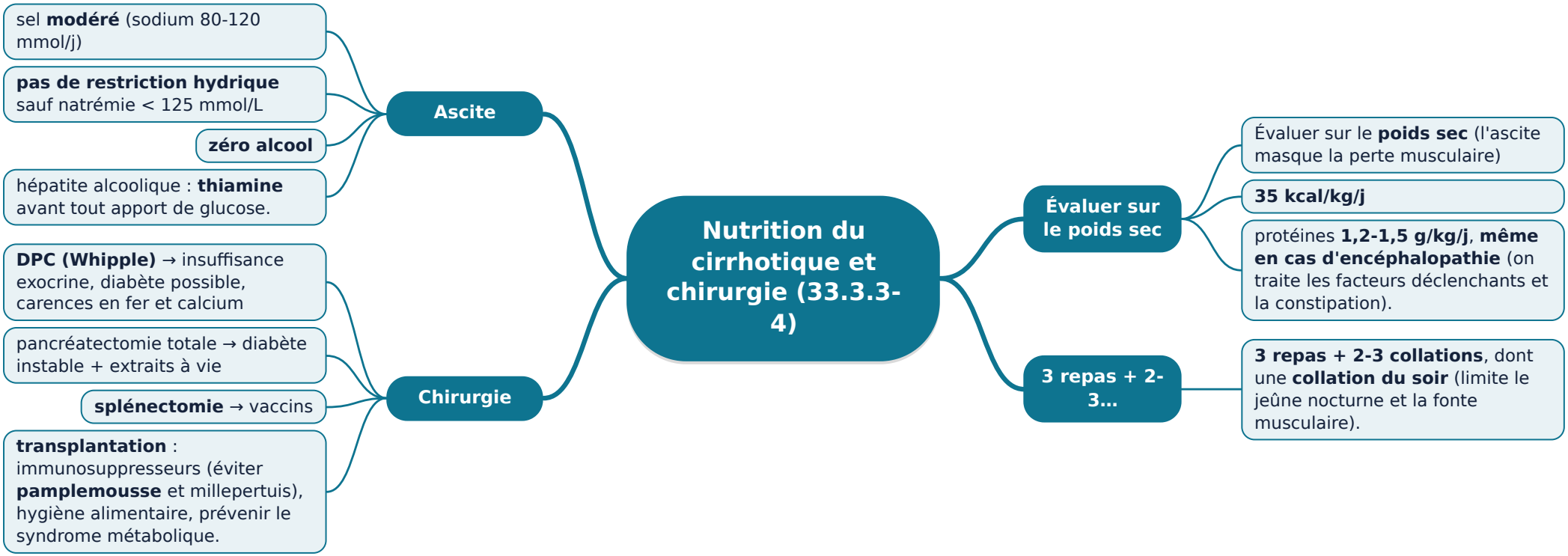

Lire un bilan hépatique et pancréatique (33.3)
HTP
Marqueurs : plaquettes ↓, ascite, varices
Conséquence diététique : sel modéré ; textures tendres si varices
Pancréas exocrine
Marqueurs : lipase > 3 N (aigu) ; élastase fécale ↓ (chronique)
Conséquence diététique : extraits pancréatiques
Ictère
bilirubine > 17 µmol/L (visible au-delà de 35-50)
libre (hémolyse, maladie de Gilbert) ≠ conjuguée (cholestase : urines foncées, selles décolorées, prurit).
Cytolyse
Marqueurs : ALAT, ASAT ↑ (ALAT plus spécifiques du foie)
Conséquence diététique : arrêt alcool et produits toxiques pour le foie ; alimentation normale
Cholestase
Marqueurs : PAL, GGT ↑, bilirubine conjuguée ↑
Conséquence diététique : malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K ; TCM si besoin
Insuffisance hépatocellulaire
Marqueurs : TP, facteur V, albumine ↓ ; bilirubine ↑
Conséquence diététique : protéines élevées, collation du soir

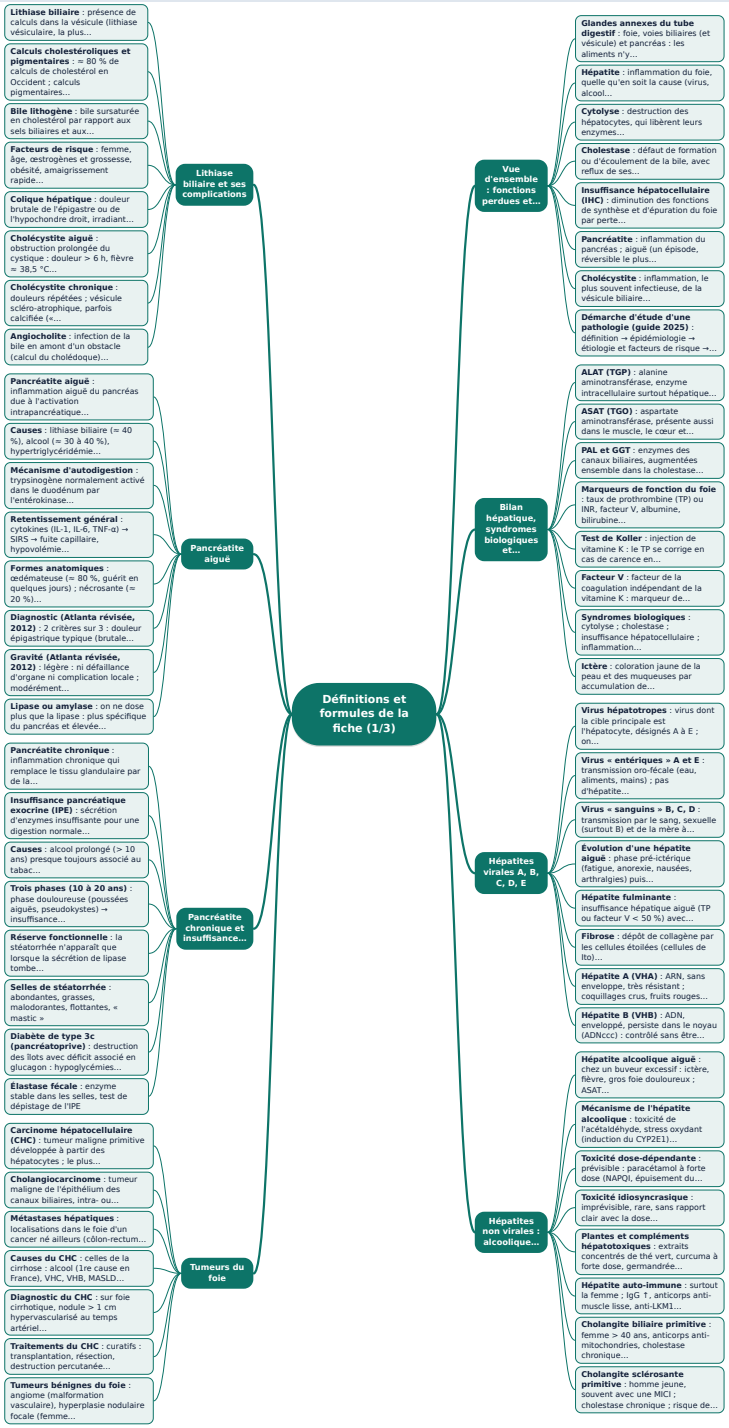

Hépatites virales (33.3.1)
B, C, D
sang, voie sexuelle, mère-enfant
B : chronicité surtout chez le nouveau-né, vaccin
C : souvent chronique, pas de vaccin mais guérison > 95 % par antiviraux
D : seulement avec le B.
Risque commun des formes chroniques
cirrhose puis CHC.
A et E
transmission féco-orale (eau, aliments ; E = zoonose du porc en France)
pas de chronicité (sauf E chez l'immunodéprimé)
vaccin contre A.

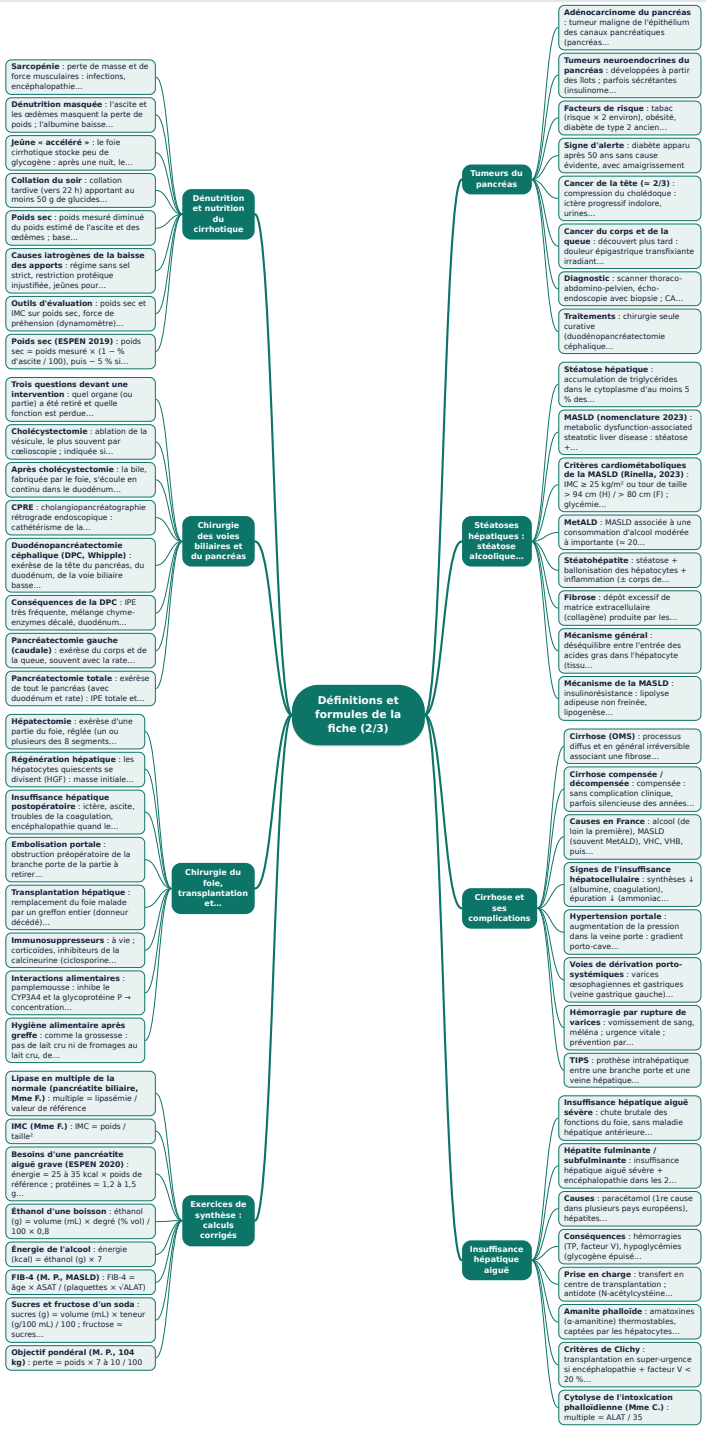

Lithiase biliaire (33.3.1)
Calculs surtout cholestéroliques
Calculs surtout **cholestéroliques** (bile sursaturée)
facteurs : femme, âge, obésité, **amaigrissement rapide**, grossesse.
Lithiase asymptomatique
ni opération ni régime
colique hépatique (douleur sans fièvre)
cholécystite (douleur + fièvre)
angiocholite (douleur → fièvre → ictère)
pancréatite biliaire.
Traitement de la lithiase symptomatique
cholécystectomie
après : **pas de régime** (la bile continue de couler du foie vers le duodénum).

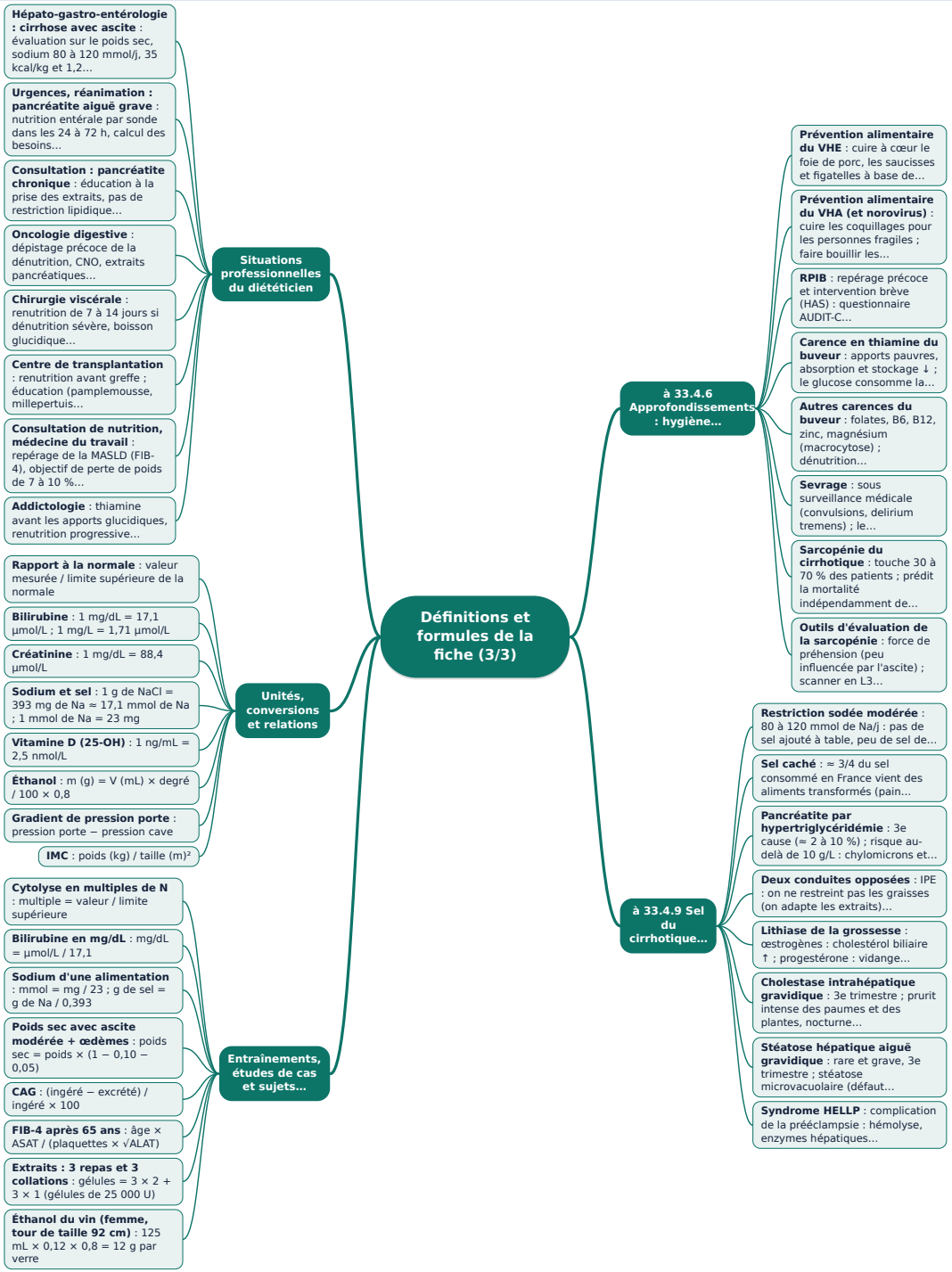

Pancréatites et cancer du pancréas (33.3.1-2)
Pancréatite chronique (alcool + tabac)
douleur, calcifications, **insuffisance exocrine** (stéatorrhée, carence en vitamines A, D, E, K) et **diabète de type 3c** (insuline et glucagon ↓ →...
30-35 kcal/kg/j
pas de restriction des graisses
extraits pancréatiques à chaque repas, **au début**.
Cancer du pancréas
pronostic sombre
tête → **ictère indolore + grosse vésicule**
dénutrition fréquente
minorité opérable.
Pancréatite aiguë
causes principales **lithiase biliaire** et **alcool**
activation de la trypsine dans le pancréas
diagnostic = **2 critères sur 3** (douleur, lipase > 3 N, imagerie)
gravité = **défaillances d'organes** (pas le taux de lipase).
Nutrition
reprise orale précoce
forme grave : **entérale dans les 24-72 h** (moins d'infections que la parentérale)
parentérale en dernier recours.

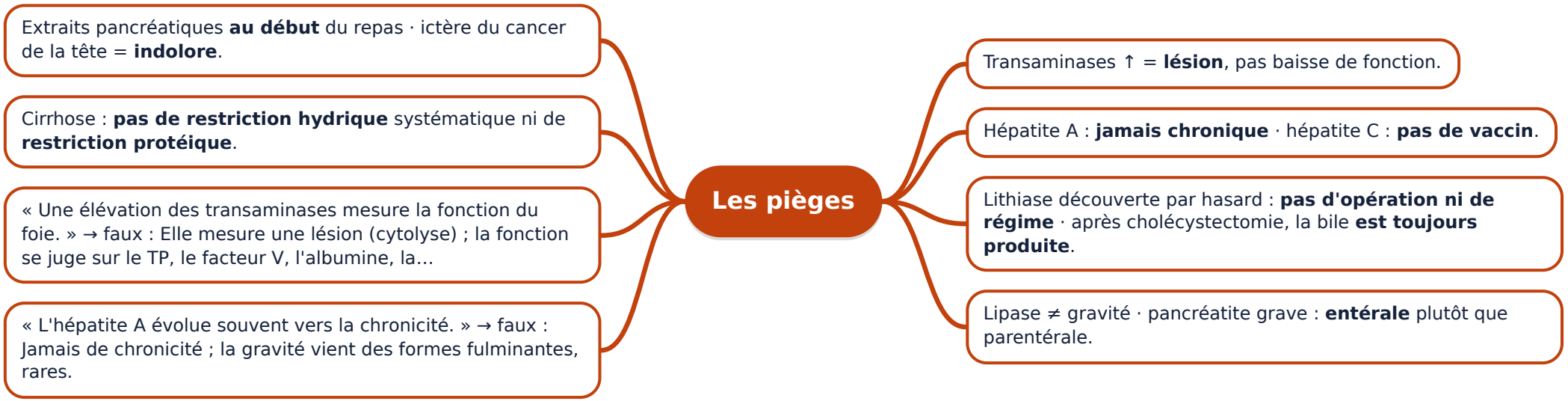

Stéatose, cirrhose et cancer du foie (33.3.2-3)
Cirrhose
Cirrhose = fibrose diffuse + nodules de régénération → insuffisance hépatocellulaire + HTP (varices œsophagiennes, splénomégalie, ascite)
complications : hémorragie, ascite infectée, encéphalopathie, CHC
gravité : score de Child-Pugh A, B, C (bilirubine, albumine, TP, ascite, encéphalopathie).
Ascite
HTP + vasodilatation + rétention rénale de sodium (aldostérone), pas seulement l'albumine basse.
CHC
survient surtout sur cirrhose → échographie de surveillance tous les 6 mois.
Stéatose
Stéatose = triglycérides dans ≥ 5 % des hépatocytes
MASLD = stéatose + au moins 1 critère cardiométabolique, sans alcool excessif
évolution possible : stéatohépatite → fibrose → cirrhose.
Prise en charge MASLD
perte de poids 7-10 %, suppression des boissons sucrées, activité physique 150-300 min/semaine.

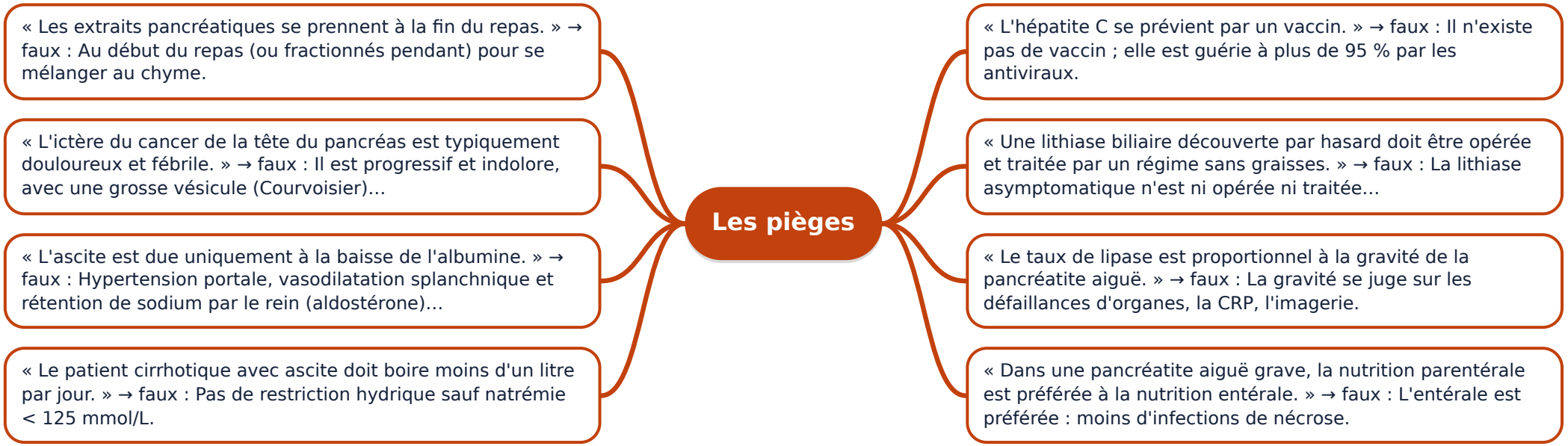

Nutrition du cirrhotique et chirurgie (33.3.3-4)
Ascite
sel modéré (sodium 80-120 mmol/j)
pas de restriction hydrique sauf natrémie < 125 mmol/L
zéro alcool
hépatite alcoolique : thiamine avant tout apport de glucose.
Chirurgie
DPC (Whipple) → insuffisance exocrine, diabète possible, carences en fer et calcium
pancréatectomie totale → diabète instable + extraits à vie
splénectomie → vaccins
transplantation : immunosuppresseurs (éviter pamplemousse et millepertuis), hygiène alimentaire, prévenir le syndrome métabolique.
Évaluer sur le poids sec
Évaluer sur le poids sec (l'ascite masque la perte musculaire)
35 kcal/kg/j
protéines 1,2-1,5 g/kg/j, même en cas d'encéphalopathie (on traite les facteurs déclenchants et la constipation).
3 repas + 2-3…
3 repas + 2-3 collations, dont une collation du soir (limite le jeûne nocturne et la fonte musculaire).


Définitions et formules de la fiche (1/3)
Lithiase biliaire et ses complications
Lithiase biliaire : présence de calculs dans la vésicule (lithiase vésiculaire, la plus...
Calculs cholestéroliques et pigmentaires : ≈ 80 % de calculs de cholestérol en Occident ; calculs pigmentaires...
Bile lithogène : bile sursaturée en cholestérol par rapport aux sels biliaires et aux...
Facteurs de risque : femme, âge, œstrogènes et grossesse, obésité, amaigrissement rapide...
Colique hépatique : douleur brutale de l'épigastre ou de l'hypochondre droit, irradiant...
Cholécystite aiguë : obstruction prolongée du cystique : douleur > 6 h, fièvre ≈ 38,5 °C...
Cholécystite chronique : douleurs répétées ; vésicule scléro-atrophique, parfois calcifiée («...
Angiocholite : infection de la bile en amont d'un obstacle (calcul du cholédoque)...
Pancréatite aiguë
Pancréatite aiguë : inflammation aiguë du pancréas due à l'activation intrapancréatique...
Causes : lithiase biliaire (≈ 40 %), alcool (≈ 30 à 40 %), hypertriglycéridémie...
Mécanisme d'autodigestion : trypsinogène normalement activé dans le duodénum par l'entérokinase...
Retentissement général : cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) → SIRS → fuite capillaire, hypovolémie...
Formes anatomiques : œdémateuse (≈ 80 %, guérit en quelques jours) ; nécrosante (≈ 20 %)...
Diagnostic (Atlanta révisée, 2012) : 2 critères sur 3 : douleur épigastrique typique (brutale...
Gravité (Atlanta révisée, 2012) : légère : ni défaillance d'organe ni complication locale ; modérément...
Lipase ou amylase : on ne dose plus que la lipase : plus spécifique du pancréas et élevée...
Pancréatite chronique et insuffisance...
Pancréatite chronique : inflammation chronique qui remplace le tissu glandulaire par de la...
Insuffisance pancréatique exocrine (IPE) : sécrétion d'enzymes insuffisante pour une digestion normale...
Causes : alcool prolongé (> 10 ans) presque toujours associé au tabac...
Trois phases (10 à 20 ans) : phase douloureuse (poussées aiguës, pseudokystes) → insuffisance...
Réserve fonctionnelle : la stéatorrhée n'apparaît que lorsque la sécrétion de lipase tombe...
Selles de stéatorrhée : abondantes, grasses, malodorantes, flottantes, « mastic »
Diabète de type 3c (pancréatoprive) : destruction des îlots avec déficit associé en glucagon : hypoglycémies...
Élastase fécale : enzyme stable dans les selles, test de dépistage de l'IPE
Tumeurs du foie
Carcinome hépatocellulaire (CHC) : tumeur maligne primitive développée à partir des hépatocytes ; le plus...
Cholangiocarcinome : tumeur maligne de l'épithélium des canaux biliaires, intra- ou...
Métastases hépatiques : localisations dans le foie d'un cancer né ailleurs (côlon-rectum...
Causes du CHC : celles de la cirrhose : alcool (1re cause en France), VHC, VHB, MASLD...
Diagnostic du CHC : sur foie cirrhotique, nodule > 1 cm hypervascularisé au temps artériel...
Traitements du CHC : curatifs : transplantation, résection, destruction percutanée...
Tumeurs bénignes du foie : angiome (malformation vasculaire), hyperplasie nodulaire focale (femme...
Vue d'ensemble : fonctions perdues et...
Glandes annexes du tube digestif : foie, voies biliaires (et vésicule) et pancréas : les aliments n'y...
Hépatite : inflammation du foie, quelle qu'en soit la cause (virus, alcool...
Cytolyse : destruction des hépatocytes, qui libèrent leurs enzymes...
Cholestase : défaut de formation ou d'écoulement de la bile, avec reflux de ses...
Insuffisance hépatocellulaire (IHC) : diminution des fonctions de synthèse et d'épuration du foie par perte...
Pancréatite : inflammation du pancréas ; aiguë (un épisode, réversible le plus...
Cholécystite : inflammation, le plus souvent infectieuse, de la vésicule biliaire...
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025) : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque →...
Bilan hépatique, syndromes biologiques et...
ALAT (TGP) : alanine aminotransférase, enzyme intracellulaire surtout hépatique...
ASAT (TGO) : aspartate aminotransférase, présente aussi dans le muscle, le cœur et...
PAL et GGT : enzymes des canaux biliaires, augmentées ensemble dans la cholestase...
Marqueurs de fonction du foie : taux de prothrombine (TP) ou INR, facteur V, albumine, bilirubine...
Test de Koller : injection de vitamine K : le TP se corrige en cas de carence en...
Facteur V : facteur de la coagulation indépendant de la vitamine K : marqueur de...
Syndromes biologiques : cytolyse ; cholestase ; insuffisance hépatocellulaire ; inflammation...
Ictère : coloration jaune de la peau et des muqueuses par accumulation de...
Hépatites virales A, B, C, D, E
Virus hépatotropes : virus dont la cible principale est l'hépatocyte, désignés A à E ; on...
Virus « entériques » A et E : transmission oro-fécale (eau, aliments, mains) ; pas d'hépatite...
Virus « sanguins » B, C, D : transmission par le sang, sexuelle (surtout B) et de la mère à...
Évolution d'une hépatite aiguë : phase pré-ictérique (fatigue, anorexie, nausées, arthralgies) puis...
Hépatite fulminante : insuffisance hépatique aiguë (TP ou facteur V < 50 %) avec...
Fibrose : dépôt de collagène par les cellules étoilées (cellules de Ito)...
Hépatite A (VHA) : ARN, sans enveloppe, très résistant ; coquillages crus, fruits rouges...
Hépatite B (VHB) : ADN, enveloppé, persiste dans le noyau (ADNccc) : contrôlé sans être...
Hépatites non virales : alcoolique...
Hépatite alcoolique aiguë : chez un buveur excessif : ictère, fièvre, gros foie douloureux ; ASAT...
Mécanisme de l'hépatite alcoolique : toxicité de l'acétaldéhyde, stress oxydant (induction du CYP2E1)...
Toxicité dose-dépendante : prévisible : paracétamol à forte dose (NAPQI, épuisement du...
Toxicité idiosyncrasique : imprévisible, rare, sans rapport clair avec la dose...
Plantes et compléments hépatotoxiques : extraits concentrés de thé vert, curcuma à forte dose, germandrée...
Hépatite auto-immune : surtout la femme ; IgG ↑, anticorps anti-muscle lisse, anti-LKM1...
Cholangite biliaire primitive : femme > 40 ans, anticorps anti-mitochondries, cholestase chronique...
Cholangite sclérosante primitive : homme jeune, souvent avec une MICI ; cholestase chronique ; risque de...


Définitions et formules de la fiche (2/3)
Dénutrition et nutrition du cirrhotique
Sarcopénie : perte de masse et de force musculaires : infections, encéphalopathie…
Dénutrition masquée : l'ascite et les œdèmes masquent la perte de poids ; l'albumine baisse…
Jeûne « accéléré » : le foie cirrhotique stocke peu de glycogène : après une nuit, le…
Collation du soir : collation tardive (vers 22 h) apportant au moins 50 g de glucides…
Poids sec : poids mesuré diminué du poids estimé de l'ascite et des œdèmes ; base…
Causes iatrogènes de la baisse des apports : régime sans sel strict, restriction protéique injustifiée, jeûnes pour…
Outils d'évaluation : poids sec et IMC sur poids sec, force de préhension (dynamomètre)…
Poids sec (ESPEN 2019) : poids sec = poids mesuré × (1 − % d'ascite / 100), puis − 5 % si…
Chirurgie des voies biliaires et du pancréas
Trois questions devant une intervention : quel organe (ou partie) a été retiré et quelle fonction est perdue…
Cholécystectomie : ablation de la vésicule, le plus souvent par cœlioscopie ; indiquée si…
Après cholécystectomie : la bile, fabriquée par le foie, s'écoule en continu dans le duodénum…
CPRE : cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique : cathétérisme de la…
Duodénopancréatectomie céphalique (DPC, Whipple) : exérèse de la tête du pancréas, du duodénum, de la voie biliaire basse…
Conséquences de la DPC : IPE très fréquente, mélange chyme-enzymes décalé, duodénum…
Pancréatectomie gauche (caudale) : exérèse du corps et de la queue, souvent avec la rate…
Pancréatectomie totale : exérèse de tout le pancréas (avec duodénum et rate) : IPE totale et…
Chirurgie du foie, transplantation et…
Hépatectomie : exérèse d'une partie du foie, réglée (un ou plusieurs des 8 segments…
Régénération hépatique : les hépatocytes quiescents se divisent (HGF) : masse initiale…
Insuffisance hépatique postopératoire : ictère, ascite, troubles de la coagulation, encéphalopathie quand le…
Embolisation portale : obstruction préopératoire de la branche porte de la partie à retirer…
Transplantation hépatique : remplacement du foie malade par un greffon entier (donneur décédé)…
Immunosuppresseurs : à vie ; corticoïdes, inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine…
Interactions alimentaires : pamplemousse : inhibe le CYP3A4 et la glycoprotéine P → concentration…
Hygiène alimentaire après greffe : comme la grossesse : pas de lait cru ni de fromages au lait cru, de…
Exercices de synthèse : calculs corrigés
Lipase en multiple de la normale (pancréatite biliaire, Mme F.) : multiple = lipasémie / valeur de référence
IMC (Mme F.) : IMC = poids / taille²
Besoins d'une pancréatite aiguë grave (ESPEN 2020) : énergie = 25 à 35 kcal × poids de référence ; protéines = 1,2 à 1,5 g…
Éthanol d'une boisson : éthanol (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8
Énergie de l'alcool : énergie (kcal) = éthanol (g) × 7
FIB-4 (M. P., MASLD) : FIB-4 = âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)
Sucres et fructose d'un soda : sucres (g) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100 ; fructose ≈ sucres…
Objectif pondéral (M. P., 104 kg) : perte = poids × 7 à 10 / 100
Tumeurs du pancréas
Adénocarcinome du pancréas : tumeur maligne de l'épithélium des canaux pancréatiques (pancréas…
Tumeurs neuroendocrines du pancréas : développées à partir des îlots ; parfois sécrétantes (insulinome…
Facteurs de risque : tabac (risque × 2 environ), obésité, diabète de type 2 ancien…
Signe d'alerte : diabète apparu après 50 ans sans cause évidente, avec amaigrissement
Cancer de la tête (≈ 2/3) : compression du cholédoque : ictère progressif indolore, urines…
Cancer du corps et de la queue : découvert plus tard : douleur épigastrique transfixiante irradiant…
Diagnostic : scanner thoraco-abdomino-pelvien, écho-endoscopie avec biopsie ; CA…
Traitements : chirurgie seule curative (duodénopancréatectomie céphalique…
Stéatoses hépatiques : stéatose alcoolique…
Stéatose hépatique : accumulation de triglycérides dans le cytoplasme d'au moins 5 % des…
MASLD (nomenclature 2023) : metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease : stéatose +…
Critères cardiométaboliques de la MASLD (Rinella, 2023) : IMC ≥ 25 kg/m² ou tour de taille > 94 cm (H) / > 80 cm (F) ; glycémie…
MetALD : MASLD associée à une consommation d'alcool modérée à importante (≈ 20…
Stéatohépatite : stéatose + ballonisation des hépatocytes + inflammation (± corps de…
Fibrose : dépôt excessif de matrice extracellulaire (collagène) produite par les…
Mécanisme général : déséquilibre entre l'entrée des acides gras dans l'hépatocyte (tissu…
Mécanisme de la MASLD : insulinorésistance : lipolyse adipeuse non freinée, lipogenèse…
Cirrhose et ses complications
Cirrhose (OMS) : processus diffus et en général irréversible associant une fibrose…
Cirrhose compensée / décompensée : compensée : sans complication clinique, parfois silencieuse des années…
Causes en France : alcool (de loin la première), MASLD (souvent MetALD), VHC, VHB, puis…
Signes de l'insuffisance hépatocellulaire : synthèses ↓ (albumine, coagulation), épuration ↓ (ammoniac…
Hypertension portale : augmentation de la pression dans la veine porte : gradient porto-cave…
Voies de dérivation porto-systémiques : varices œsophagiennes et gastriques (veine gastrique gauche)…
Hémorragie par rupture de varices : vomissement de sang, méléna ; urgence vitale ; prévention par…
TIPS : prothèse intrahépatique entre une branche porte et une veine hépatique…
Insuffisance hépatique aiguë
Insuffisance hépatique aiguë sévère : chute brutale des fonctions du foie, sans maladie hépatique antérieure…
Hépatite fulminante / subfulminante : insuffisance hépatique aiguë sévère + encéphalopathie dans les 2…
Causes : paracétamol (1re cause dans plusieurs pays européens), hépatites…
Conséquences : hémorragies (TP, facteur V), hypoglycémies (glycogène épuisé…
Prise en charge : transfert en centre de transplantation ; antidote (N-acétylcystéine…
Amanite phalloïde : amatoxines (α-amanitine) thermostables, captées par les hépatocytes…
Critères de Clichy : transplantation en super-urgence si encéphalopathie + facteur V < 20 %…
Cytolyse de l'intoxication phalloïdienne (Mme C.) : multiple = ALAT / 35


Définitions et formules de la fiche (3/3)
Situations professionnelles du diététicien
Hépato-gastro-entérologie : cirrhose avec ascite : évaluation sur le poids sec, sodium 80 à 120 mmol/j, 35 kcal/kg et 1,2…
Urgences, réanimation : pancréatite aiguë grave : nutrition entérale par sonde dans les 24 à 72 h, calcul des besoins…
Consultation : pancréatite chronique : éducation à la prise des extraits, pas de restriction lipidique…
Oncologie digestive : dépistage précoce de la dénutrition, CNO, extraits pancréatiques…
Chirurgie viscérale : renutrition de 7 à 14 jours si dénutrition sévère, boisson glucidique…
Centre de transplantation : renutrition avant greffe ; éducation (pamplemousse, millepertuis…
Consultation de nutrition, médecine du travail : repérage de la MASLD (FIB-4), objectif de perte de poids de 7 à 10 %…
Addictologie : thiamine avant les apports glucidiques, renutrition progressive…
Unités, conversions et relations
Rapport à la normale : valeur mesurée / limite supérieure de la normale
Bilirubine : 1 mg/dL = 17,1 µmol/L ; 1 mg/L = 1,71 µmol/L
Créatinine : 1 mg/dL = 88,4 µmol/L
Sodium et sel : 1 g de NaCl = 393 mg de Na ≈ 17,1 mmol de Na ; 1 mmol de Na = 23 mg
Vitamine D (25-OH) : 1 ng/mL = 2,5 nmol/L
Éthanol : m (g) = V (mL) × degré / 100 × 0,8
Gradient de pression porte : pression porte − pression cave
IMC : poids (kg) / taille (m)²
Entraînements, études de cas et sujets…
Cytolyse en multiples de N : multiple = valeur / limite supérieure
Bilirubine en mg/dL : mg/dL = µmol/L / 17,1
Sodium d'une alimentation : mmol = mg / 23 ; g de sel = g de Na / 0,393
Poids sec avec ascite modérée + œdèmes : poids sec = poids × (1 − 0,10 − 0,05)
CAG : (ingéré − excrété) / ingéré × 100
FIB-4 après 65 ans : âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)
Extraits : 3 repas et 3 collations : gélules = 3 × 2 + 3 × 1 (gélules de 25 000 U)
Éthanol du vin (femme, tour de taille 92 cm) : 125 mL × 0,12 × 0,8 = 12 g par verre
à 33.4.6 Approfondissements : hygiène…
Prévention alimentaire du VHE : cuire à cœur le foie de porc, les saucisses et figatelles à base de…
Prévention alimentaire du VHA (et norovirus) : cuire les coquillages pour les personnes fragiles ; faire bouillir les…
RPIB : repérage précoce et intervention brève (HAS) : questionnaire AUDIT-C…
Carence en thiamine du buveur : apports pauvres, absorption et stockage ↓ ; le glucose consomme la…
Autres carences du buveur : folates, B6, B12, zinc, magnésium (macrocytose) ; dénutrition…
Sevrage : sous surveillance médicale (convulsions, delirium tremens) ; le…
Sarcopénie du cirrhotique : touche 30 à 70 % des patients ; prédit la mortalité indépendamment de…
Outils d'évaluation de la sarcopénie : force de préhension (peu influencée par l'ascite) ; scanner en L3…
à 33.4.9 Sel du cirrhotique…
Restriction sodée modérée : 80 à 120 mmol de Na/j : pas de sel ajouté à table, peu de sel de…
Sel caché : ≈ 3/4 du sel consommé en France vient des aliments transformés (pain…
Pancréatite par hypertriglycéridémie : 3e cause (≈ 2 à 10 %) ; risque au-delà de 10 g/L : chylomicrons et…
Deux conduites opposées : IPE : on ne restreint pas les graisses (on adapte les extraits)…
Lithiase de la grossesse : œstrogènes : cholestérol biliaire ↑ ; progestérone : vidange…
Cholestase intrahépatique gravidique : 3e trimestre ; prurit intense des paumes et des plantes, nocturne…
Stéatose hépatique aiguë gravidique : rare et grave, 3e trimestre ; stéatose microvacuolaire (défaut…
Syndrome HELLP : complication de la prééclampsie : hémolyse, enzymes hépatiques…


Les pièges
Extraits pancréatiques **au début** du repas · ictère du cancer de la tête = **indolore**.
Cirrhose : **pas de restriction hydrique** systématique ni de **restriction protéique**.
« Une élévation des transaminases mesure la fonction du foie. » → faux : Elle mesure une lésion (cytolyse) ; la fonction se juge sur le TP, le facteur V, l'albumine, la…
« L'hépatite A évolue souvent vers la chronicité. » → faux : Jamais de chronicité ; la gravité vient des formes fulminantes, rares.
Transaminases ↑ = **lésion**, pas baisse de fonction.
Hépatite A : **jamais chronique** · hépatite C : **pas de vaccin**.
Lithiase découverte par hasard : **pas d'opération ni de régime** · après cholécystectomie, la bile **est toujours produite**.
Lipase ≠ gravité · pancréatite grave : **entérale** plutôt que parentérale.


Les pièges
« Les extraits pancréatiques se prennent à la fin du repas. » → faux : Au début du repas (ou fractionnés pendant) pour se mélanger au chyme.
« L'ictère du cancer de la tête du pancréas est typiquement douloureux et fébrile. » → faux : Il est progressif et indolore, avec une grosse vésicule (Courvoisier)…
« L'ascite est due uniquement à la baisse de l'albumine. » → faux : Hypertension portale, vasodilatation splanchnique et rétention de sodium par le rein (aldostérone)…
« Le patient cirrhotique avec ascite doit boire moins d'un litre par jour. » → faux : Pas de restriction hydrique sauf natrémie < 125 mmol/L.
« L'hépatite C se prévient par un vaccin. » → faux : Il n'existe pas de vaccin ; elle est guérie à plus de 95 % par les antiviraux.
« Une lithiase biliaire découverte par hasard doit être opérée et traitée par un régime sans graisses. » → faux : La lithiase asymptomatique n'est ni opérée ni traitée…
« Le taux de lipase est proportionnel à la gravité de la pancréatite aiguë. » → faux : La gravité se juge sur les défaillances d'organes, la CRP, l'imagerie.
« Dans une pancréatite aiguë grave, la nutrition parentérale est préférée à la nutrition entérale. » → faux : L'entérale est préférée : moins d'infections de nécrose.